



La salud mental de la infancia migrante centra la Jornada Mundial del Migrante, el Gobierno se compromete a una futura Ley de Profesiones de la Intervención Social y un ensayo del COP evalúa las intervenciones psicológicas en centros educativos: claves del 25 de septiembre de 2026

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

Coincidiendo con la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, distintos organismos internacionales ponen el foco en la salud mental de la infancia en contextos de migración. El Consejo General de la Psicología valora la previsión de una futura Ley de Profesiones de la Intervención Social, incluida en la reforma de discapacidad y dependencia ya aprobada. La EFPA suma un nuevo miembro de pleno derecho procedente de Macedonia del Norte. Y un ensayo controlado aleatorizado desarrollado en 85 centros educativos españoles analiza los beneficios de las intervenciones psicológicas grupales en adolescentes con síntomas emocionales subclínicos.

Noticias nacionales

La salud mental de la infancia migrante y refugiada, en el punto de mira ante la Jornada Mundial del Migrante

Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra cada 27 de septiembre, Infocop ha recopilado datos y recomendaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ACNUR, UNICEF España y el Ministerio de Sanidad sobre la salud mental de la infancia en contextos de migración. Según ACNUR, 117,8 millones de personas se encontraban desplazadas forzosamente en todo el mundo al finalizar 2025, de las cuales se estima que 45 millones eran menores de 18 años, aproximadamente el 38% del total; entre la población refugiada y otras categorías contempladas por ACNUR, los menores representan en torno al 39%, frente al 29% que suponen en la población mundial. La OMS señala que la exposición a conflictos, violencia, pérdidas o incertidumbre prolongada se asocia a mayor riesgo de ansiedad, trastornos del sueño y, en algunos casos, depresión o estrés postraumático, aunque advierte de que la condición migratoria no debe identificarse automáticamente con una peor salud mental. Un informe mundial de la OMS publicado en marzo de 2026, basado en una encuesta a 93 Estados Miembros, constató que solo el 37% de los países declaró recopilar, analizar y difundir habitualmente datos sanitarios relacionados con la migración, y menos del 40% informó de formación específica para el personal sanitario en atención culturalmente adecuada. Por su parte, el Ministerio de Sanidad, en un informe presentado en junio de 2026, señala que la población nacida en España presenta mayor prevalencia en 16 de las 21 patologías analizadas y hasta un 65% más de casos con tres o más problemas crónicos de salud, lo que evidencia la importancia de evitar generalizaciones entre migración y salud mental.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), con datos de la OMS, ACNUR, UNICEF España y el Ministerio de Sanidad

El Gobierno se compromete a presentar en un año una Ley de Profesiones de la Intervención Social

La reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia ha culminado su tramitación parlamentaria manteniendo el compromiso de que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, un Proyecto de Ley de Profesiones de la Intervención Social. Esta previsión procede de una iniciativa impulsada por el Consejo General de la Psicología de España (COP), junto con el Consejo General del Trabajo Social y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales. La propuesta se incorporó como enmienda de Junts durante la tramitación en el Congreso, se mantuvo tras su paso por el Senado y ha quedado recogida de forma definitiva en la norma aprobada. En una entrevista concedida a Infocop, Fernando Chacón Fuertes, vocal adjunto a presidencia del COP e impulsor de la iniciativa, valora positivamente el avance, aunque recuerda que se trata de un compromiso de plazo, no de una ley ya aprobada: habrá elecciones antes de que se cumpla el año y el desarrollo del proyecto corresponderá previsiblemente a la siguiente legislatura. Chacón explica que la futura ley debería fijar la formación básica de acceso a la profesión en el ámbito de la intervención social y reconocer las competencias de los psicólogos y psicólogas en esta área, con un desarrollo posterior en reglamentos y protocolos. Señala como precedente la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPVI), que ya estableció que los equipos de intervención con menores víctimas de violencia estuvieran formados preferentemente por profesionales de la psicología, la educación social y el trabajo social. Entre los objetivos de la futura regulación figura también la prevención del intrusismo profesional.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), entrevista a Fernando Chacón Fuertes

Noticias internacionales

NORMATIVA · INTERNACIONAL

La EFPA incorpora a la Cámara de Psicología de Macedonia del Norte como su 38.º miembro de pleno derecho

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) ha anunciado la incorporación de la Cámara de Psicología de Macedonia del Norte como su

38.º miembro de pleno derecho. La admisión fue aprobada durante la Asamblea General Ordinaria de la Federación, celebrada en junio de 2026. En su solicitud de adhesión, la Cámara destacó su compromiso con la adaptación a los estándares profesionales europeos actuales, entre ellos el certificado EuroPsy que la EFPA promueve como marco común de cualificación para psicólogos en Europa, y señaló su intención de fortalecer la colaboración para avanzar en psicología y salud mental en el continente. La EFPA ha dado la bienvenida al nuevo miembro y ha expresado su voluntad de trabajar conjuntamente en la promoción de la excelencia profesional, el fomento de la colaboración transfronteriza y el apoyo a la contribución de la psicología al bienestar de las personas y las sociedades europeas. La Federación agrupa actualmente asociaciones nacionales de psicólogos de 37 países europeos, entre ellos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y trabaja en el desarrollo de estándares profesionales comunes y en la representación de la psicología ante instituciones europeas.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), con información de la EFPA

Publicaciones científicas recientes

Fonseca-Pedrero, E., Pérez-Esteban, A., Díez-Gómez, A., Pérez-Albéniz, A., Al-Halabí, S., Lucas-Molina, B., & Debbané, M. (2026). A multicenter randomized controlled effectiveness trial of transdiagnostic treatment for adolescents with subthreshold anxiety and depressive symptoms. *Psychological Medicine*, 56, e264, 1–13.

DOI: [10.1017/S0033291726105443](https://doi.org/10.1017/S0033291726105443)

Hallazgo: Se trata de un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico, enmarcado en el proyecto PsiCE del Consejo General de la Psicología de España (COP) y PSICOFUNDACIÓN, desarrollado por investigadores de las universidades de La Rioja, Oviedo y Valencia junto con la Universidad de Ginebra. En la fase de cribado se evaluó a 8.746 estudiantes de 85 centros educativos y 532 aulas de nueve provincias españolas; finalmente participaron 676 adolescentes con síntomas subclínicos moderados de ansiedad y depresión (edad media 13,77 años; 72,6% chicas), que fueron distribuidos aleatoriamente entre el Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los Problemas Emocionales en Adolescentes (UP-A, 378

participantes) y un grupo de control activo basado en relajación progresiva protocolizada (298 participantes), con diez sesiones grupales de 50 minutos en ambos casos y seguimientos a los 6 y 12 meses. Ambas intervenciones mostraron reducciones significativas de los síntomas depresivos y ansiosos a lo largo del tiempo, sin diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en estos resultados principales: en el PHQ-9, la puntuación media del grupo UP-A pasó de 12,43 a 7,11 puntos al año, y en el GAD-7, de 12,48 a 6,94 puntos. A los doce meses, el 78,5% de quienes recibieron el UP-A había reducido al menos un 30% sus síntomas depresivos. El grupo UP-A mostró, además, diferencias favorables en resultados secundarios relacionados con hiperactividad, problemas de conducta y dificultades totales de salud mental, que los propios autores piden interpretar con cautela por el elevado número de comparaciones realizadas.

Implicación clínica: Los propios autores y autoras señalan que la ausencia de diferencias claras entre las dos intervenciones sugiere que las mejoras observadas podrían no depender únicamente de las técnicas específicas de cada protocolo, sino también de factores comunes como la atención estructurada, la validación emocional y las interacciones grupales de apoyo. Puede ser relevante entender estos resultados como un respaldo, de forma general, al potencial de las intervenciones psicológicas grupales y estructuradas en el contexto educativo para adolescentes con síntomas emocionales subclínicos, más que como evidencia de la superioridad de un protocolo concreto sobre otro.

Prioridades del día

Cribado y coordinación en atención a población migrante y refugiada

A la vista de los datos recogidos por la OMS y ACNUR, puede ser útil explorar, en la práctica clínica y comunitaria, protocolos de acogida que no den por hecho un peor estado de salud mental en las personas migrantes y que presten especial atención a la infancia no acompañada, dado su mayor riesgo de explotación y desprotección.

Seguimiento de la futura Ley de Profesiones de la Intervención Social

Dado que el desarrollo de esta ley se extenderá más allá del año previsto y dependerá de la siguiente legislatura, puede ser oportuno seguir su tramitación a través de los canales del Consejo General de la Psicología, especialmente para quienes desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la intervención social con familias, infancia o colectivos vulnerables.

Intervenciones grupales estructuradas en contextos educativos

A partir de los resultados del ensayo PsiCE, puede ser relevante valorar el papel de las intervenciones grupales y estructuradas en centros educativos como recurso preventivo para adolescentes con sintomatología emocional subclínica, sin que ello implique sustituir la evaluación y el tratamiento individualizado cuando estén clínicamente indicados.